

MediPlan

Refonte du système de prise de rendez-vous médicaux

Équipe projet

Abd-ellah Chef de projet

Arthur Product Owner

Hervé Analyste technique

Sommaire

I. Étude d'opportunité

- 1.1 Contexte et problématique
- 1.2 Analyse du besoin et des utilisateurs
- 1.3 Benchmark concurrentiel (Doctolib, Maiia, Keldoc)
- 1.4 Bénéfices attendus et ROI estimé
- 1.5 Risques stratégiques
- 1.6 Recommandation Go / No-Go

I. Étude d'opportunité

Contexte et problématique

Le point de départ, c'est un logiciel desktop vieillissant, installé poste par poste au secrétariat et inaccessible depuis l'extérieur. Pas d'accès patient, pas d'accès médecin à distance : tout converge vers le téléphone et vers les mains des secrétaires. Prendre un rendez-vous, le déplacer ou l'annuler suppose d'appeler aux heures d'ouverture, de tomber sur une ligne libre et de s'en remettre à la personne au bout du fil pour saisir l'information sans erreur.

Le système fonctionne, il a tenu des années mais il fait reposer toute la chaîne sur un canal unique, et le canal sature.

Le premier symptôme se lit dans les volumes. L'établissement traite autour de 30 000 rendez-vous par an, et plus de 40 % du temps des secrétaires part dans la prise de RDV (rendez-vous) au téléphone. Ce n'est pas du temps gâché au sens strict chaque appel rend un service mais c'est du temps capté par une tâche répétitive, au détriment de l'accueil physique, de l'accompagnement des patients perdus avec le numérique et du traitement des cas complexes, c'est-à-dire là où une présence humaine est réellement irremplaçable.

Le second symptôme coûte plus cher encore, et il reste invisible dans les chiffres du quotidien : près de 25 % des rendez-vous ne sont pas honorés. Un patient sur quatre ne se présente pas. La cause n'a rien d'obscur, l'organisation actuelle ne laisse aucune trace écrite côté patient. On raccroche après avoir convenu d'un créneau à l'oral, sans confirmation ni rappel, et le rendez-vous se dilue dans un emploi du temps chargé jusqu'à l'oubli pur et simple. Derrière chaque no-show, il y a un créneau immobilisé, un médecin qui attend, un plateau technique qui tourne à vide et surtout un autre patient qui aurait pu prendre la place et qui patiente, lui, plusieurs semaines.

Mis bout à bout, ces deux symptômes dessinent le vrai problème. L'hôpital s'appuie sur un outil interne qui n'a jamais été pensé pour le patient, et il compense ce manque par du temps humain qu'il paie ensuite en rendez-vous perdus. La question posée à la direction ne se limite donc pas à remplacer un logiciel fatigué : il s'agit de décider si l'établissement ouvre la prise de rendez-vous au patient lui-même en autonomie, depuis son téléphone, avec confirmation immédiate et rappels automatiques pour désengorger le standard et reprendre la main sur le no-show. Le tout sans transiger sur une contrainte qui, elle, n'est pas négociable : on manipule des données de santé, donc un hébergement HDS (Hébergement de Données de Santé) certifié et une conformité RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) stricte, posés dès la conception et non rattrapés après coup.

Analyse du besoin et du contexte

Cinq profils gravitent autour du système actuel, trois en portent l'usage quotidien, deux pèsent dans la décision sans interagir directement avec l'outil. Tous ont été cartographiés avant les user stories du backlog. Ici est rédigée la synthèse à destination de la direction.

Le patient. Monsieur tout le monde, sans pré-requis technique. Il se connecte depuis son téléphone dans les transports, depuis son canapé un soir, parfois depuis l'accueil de l'hôpital avec une connexion qui rame. Son point commun d'une session à l'autre : sa charge

mentale est ailleurs. Il pense à sa santé, à son emploi du temps, au dernier mot du médecin pas à l'outil.

Ce qu'il veut, c'est trouver un créneau, le réserver, recevoir une confirmation et oublier MediPlan jusqu'au rappel automatique.

Aujourd'hui : il appelle un standard saturé, négocie un créneau à l'oral, raccroche sans trace écrite et oublie parfois purement et simplement son RDV. Les 25 % de no-show observés ont une cause directe : aucune confirmation écrite immédiate côté patient, aucun rappel automatisé.

Le médecin. Pro dans son métier, mais n'est pas habitué aux outils numériques. Entre deux consultations, il a quinze secondes à deux minutes pour ouvrir son planning, le lire et passer à la suite. Il sera intransigeant sur la vitesse d'affichage et la lisibilité et sur la possibilité de paramétrer ses plages une fois pour toutes sans avoir à y revenir chaque semaine.

Ses frustrations actuelles : un secrétariat qui pose des RDV sans toujours connaître ses contraintes du moment, des erreurs de double réservation à corriger en urgence, une absence de visibilité au-delà de quinze jours.

La secrétaire médicale. Quinze ETP (Équivalent Temps Plein) sur l'établissement, en première ligne du standard téléphonique. C'est le profil qui change le plus avec MediPlan. Une partie significative de son temps actuel est absorbée par la prise de RDV téléphonique un volume qui peut atteindre [jusqu'à cinquante appels quotidiens par poste](#). L'objectif n'est pas de la remplacer mais de redéployer ce temps sur des missions à valeur : accueil physique, accompagnement des patients en difficulté numérique, gestion des cas complexes. La conduite du changement la concerne en priorité.

Restent deux acteurs qui ne touchent pas l'outil au quotidien mais qui en conditionnent l'existence : la **DSI** et le **DPO** de l'hôpital. La Direction des Systèmes d'Information arbitre tout ce qui touche à l'architecture, au choix de l'hébergeur HDS et à l'intégration au SIH (Système d'Information Hospitalier) existant c'est elle qui dira si la solution proposée est tenable côté infra. Le Délégué à la Protection des Données, lui, porte la conformité RGPD et la formalisation de l'AIPD (Analyse d'Impact relative à la Protection des Données), obligatoire pour un traitement de données de santé à cette échelle. Ni l'un ni l'autre n'est utilisateur au sens fonctionnel, mais leur validation conditionne le go-live. On les engage dès le sprint de cadrage, pas une fois que les choix sont faits sinon on découvre les blocages trop tard.

Benchmark concurrentiel (Doctolib, Maia, Keldoc)

Avant de recommander quoi que ce soit, on a regardé ce qui existe déjà. Le marché français de la prise de RDV médical est mûr, dominé par deux plateformes grand public, avec un troisième acteur plus discret mais taillé pour le contexte hospitalier. L'exercice n'est pas de copier ces solutions c'est de comprendre pourquoi, malgré leur qualité, aucune ne répond exactement au besoin d'un hôpital qui veut garder la main sur son parcours patient.

Doctolib, c'est le leader et de loin : environ 80 % du marché français, plus de 250 000 praticiens et des dizaines de millions de RDV par mois, avec une présence en Allemagne et en Italie. Sa force, c'est d'abord sa notoriété grand public un patient qui cherche un médecin pense Doctolib avant de penser à l'hôpital, et ça remplit un agenda tout seul. L'UX (User Experience) est aboutie, le produit éprouvé. Pour un cabinet de ville, le calcul est vite fait. Pour un hôpital, c'est plus ambigu : on devient un profil sur la plateforme d'un tiers, le patient entre dans l'écosystème Doctolib autant que dans celui de l'établissement, et la donnée vit en partie chez l'éditeur. L'abonnement se paie par praticien et par mois historiquement de l'ordre de 100 € ce qui, multiplié par les effectifs d'un CH (Centre Hospitalier), devient une ligne budgétaire récurrente loin d'être négligeable.

Maia est le deuxième acteur, filiale du groupe Cegedim, avec de l'ordre de 3,5 millions d'utilisateurs actifs et 35 000 praticiens. Gratuit côté patient, autour de 99 € par mois et par praticien côté pro. Son argument différenciant tient en un mot : la souveraineté. Les données sont hébergées sur cegedim.cloud, certifié ISO 27001 et hébergeur de données de santé, avec des datacenters en France métropolitaine, et la solution s'intègre à l'écosystème logiciel Cegedim déjà présent dans beaucoup de cabinets. Moins de notoriété grand public que Doctolib donc un effet d'attraction patient plus faible mais un positionnement « données en France » qui parle directement à une DSI hospitalière prudente.

Keldoc, enfin, est le plus proche de notre sujet même s'il est le moins connu du grand public. Créé en 2012, il fait partie du groupe Doctolib depuis 2020 tout en gardant une offre distincte et c'est l'angle mort à garder en tête : derrière une marque qui se présente comme alternative, c'est le même groupe que le leader. Son intérêt réel, c'est qu'il est conçu pour l'hôpital : des connecteurs HL7 (Health Level 7) SIU (Scheduling Information Unsolicited) et des webservices qui s'interfaçent avec les DPI (Dossier Patient Informatisé) existants (Orbis, Sillage, DxCare...), et des références concrètes en centres hospitaliers comme Arles, Béziers, Foch ou Versailles.

Hébergement sur serveurs certifiés HDS en France, dans le respect du RGPD. Le modèle tarifaire est modulaire, sur devis, orienté établissement plutôt que praticien isolé. C'est la solution qui ressemble le plus à ce qu'un hôpital attend et précisément pour ça, elle montre ce qu'on devrait savoir faire nous-mêmes.

Ce qu'on en retient pour MediPlan tient en une bascule. Les trois affichent la conformité RGPD et l'hébergement HDS : sur ce critère, le marché s'est aligné, c'est devenu un prérequis et non un différenciateur. Le vrai clivage est ailleurs. Ces plateformes sont des SaaS (Software as a Service) où l'établissement loue une place dans l'écosystème d'un éditeur. C'est rationnel pour un cabinet, ça l'est beaucoup moins pour un hôpital qui veut maîtriser son parcours patient, sa donnée et son intégration au SIH sans dépendre d'un tiers dominant. Le benchmark ne disqualifie pas ces solutions il cadre la vraie question, celle du build-vs-buy qu'on tranche dans la note de cadrage : adopter une plateforme

existante, ou construire un outil dont l'hôpital reste propriétaire. MediPlan fait le second pari, et c'est l'analyse concurrentielle qui le justifie.

Pour qui veut comparer d'un coup d'œil plutôt que de lire le détail, voici la même analyse condensée sur les quatre axes attendus fonctionnalités, tarif, forces et faiblesses, conformité. C'est le tableau qui accompagne l'argument développé plus haut.

Critère	Doctolib	Maiia	Keldoc
Fonctionnalités clés	RDV, agenda, téléconsultation, rappels	RDV, agenda, téléconsultation, messagerie sécurisée	RDV, interopérabilité DPI (HL7), rappels, portail établissement.
Modèle tarifaire	100€ /mois/praticien, gratuit patient	99€/mois/praticien , gratuit patient	Sur devis, orienté établissement, gratuit patient
Forces / faiblesses	Notoriété + UX / dépendance plateforme, donnée chez l'éditeur	Souveraineté des données FR / notoriété patient plus faible	Conçu pour l'hôpital, interop SIH / Même groupe que Doctolib, tarif opaque
Conformité RGPD / HDS	HDS + RGPD affichés	HDS (cagedim.cloud FR), ISO 27001	HDS France, RGPD

Bénéfices attendus et ROI estimé

Un projet de cadrage ne se justifie pas par son nombre de technos incroyable mais par ce qu'il rapporte une fois en production en terme de scalabilité et de performances.

La bonne nouvelle, c'est que MediPlan rembourse son temps de développement par des gains opérationnels récurrents une fois l'application mise en production, pas par une promesse vague.

Deux leviers portent l'essentiel de la valeur, le reste est intangible mais loin d'être négligeable.

Le premier levier, c'est le no-show. On part de 25 % de rendez-vous non honorés, dans la moyenne nationale du milieu hospitalier, et on vise moins de 10 % à six mois. Ces quinze points ne sont pas une statistique abstraite : chaque créneau perdu, c'est un médecin qui attend, un plateau technique immobilisé, et surtout un autre patient qui aurait pu être vu et ne l'a pas été. Le levier est connu et tient à une chose qu'aucun standard téléphonique ne savait offrir une confirmation écrite immédiate doublée d'un rappel automatique à 48 h puis 2 h. Sur ce poste, le bénéfice se lit d'abord en capacité de soin récupérée : un service qui récupère quinze points d'occupation, c'est plusieurs centaines de consultations par an rendues disponibles à effectif constant. Pour un établissement sous tension sur ses délais d'accès, c'est le gain qui parle le plus à la direction.

Le second levier est plus facile à chiffrer, et c'est là qu'on pose un vrai ROI (Return On Investment). Aujourd'hui, plus de 40 % du temps des secrétaires sur un effectif d'une

quinzaine d'ETP part dans la prise de RDV au téléphone. En divisant ce ratio par deux à douze mois, on libère l'équivalent d'environ trois ETP de temps secrétariat. L'intention n'est pas de supprimer des postes mais de redéployer ce temps vers ce qu'une machine ne fera jamais : l'accueil physique, l'accompagnement des patients perdus avec le numérique, la gestion des cas complexes. En valorisant ce temps à un coût chargé de l'ordre de 35 000 à 40 000 € par ETP hypothèse à affiner avec la DRH (Direction des Ressources Humaines), on parle d'environ 110 000 € de capacité par an réorientée vers des missions à valeur. Ce n'est pas une économie qui rentre en caisse, c'est de la valeur de service récupérée, et à l'échelle d'un hôpital c'est exactement ce qu'on cherche.

À côté de ces deux leviers, il y a tout ce qui ne se met pas en tableur mais qui pèse dans la décision. Une cible de 40 % de RDV pris en ligne à trois mois, c'est autant d'interactions désintermédiées et de satisfaction patient gagnée. Les doubles réservations et les erreurs de planning, qui aujourd'hui se corrigent en urgence, disparaissent structurellement. L'établissement gagne en image et en attractivité auprès des patients comme des praticiens. Et le fait de maîtriser sa donnée et son hébergement HDS plutôt que de la loger chez un éditeur tiers n'est pas qu'une posture : dans un contexte de souveraineté des données de santé, c'est un actif et un argument de conformité opposable.

Mis bout à bout, ça donne un ROI favorable sans avoir à forcer le trait. Le build coûte de l'ordre de 120 000 à 155 000 € selon le scénario, c'est un coût qu'on engage une fois. En face, les bénéfices sont récurrents et tombent chaque année : la seule valeur de temps secrétariat réorientée couvre déjà l'essentiel du build dès la première année pleine, sans même compter l'activité récupérée sur le no-show. Sur l'horizon de trois ans retenu pour le TCO (Total Cost of Ownership), le projet est largement dans le vert à partir de la deuxième année. C'est ce qui fonde la recommandation Go qu'on détaille juste après : non pas un pari, mais un investissement dont le retour est lisible et rapide.

Risques stratégiques

Les risques qui suivent ne sont pas ceux de l'analyse EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) celle-là viendra plus loin qualifier finement, probabilité par impact, les menaces techniques et de sécurité (fuite de données, double réservation, indisponibilité). Ici, on se place au niveau de la direction : quels sont les risques qui peuvent faire échouer le projet en tant que projet, et donc peser sur la décision de le lancer. Ils sont moins nombreux mais plus structurants, et chacun appelle à une vigilance dès le cadrage.

Le premier, et de loin le plus sérieux, c'est l'échec d'adoption. Tout le ROI qu'on vient de poser repose sur une hypothèse : que les médecins paramètrèrent réellement leurs plages et que les patients prennent leurs RDV en ligne au lieu d'appeler. Si les praticiens ne jouent pas le jeu, l'outil reste vide et les patients retombent sur le standard ; si les patients continuent d'appeler par habitude, le temps secrétariat n'est jamais libéré et le gain principal s'évapore. C'est un risque humain plus que technique, et c'est pour ça qu'on engage les médecins et le secrétariat dès les ateliers de cadrage, qu'on prévoit une conduite du changement et une formation dédiées, et qu'on déploie par paliers sur un service pilote plutôt que d'un bloc. L'adoption se construit, elle ne se décrète pas.

Le deuxième point le plus exposé est l'audit de sécurité externe, s'il révèle des failles critiques tardivement, leur correction empiète sur l'UAT (User Acceptance Testing) et repousse la mise en production. Ce qui ajoute un surcout à la clé. On limite ce risque en lançant un pré-audit interne dès le 3ème mois, ça permet de ne pas découvrir des problèmes au dernier moment, et en faisant remonter COPIL (Comité de Pilotage) toute décision touchant au périmètre, au budget ou au calendrier.

Le troisième est la dépendance à l'hébergeur HDS. Faire le choix du build plutôt que d'un SaaS nous rend propriétaires de l'application, mais pas de l'infrastructure : on reste tributaire d'un hébergeur certifié pour le stockage des données de santé, avec ce que ça implique de coût récurrent, de risque de lock-in et de dépendance à sa disponibilité. C'est un arbitrage assumé la certification HDS ne s'improvise pas en interne mais il doit être contractualisé proprement, avec un SLA (Service Level Agreement) explicite et une réversibilité prévue, pour ne pas troquer une dépendance à un éditeur contre une dépendance à un hébergeur.

Le dernier, c'est le risque de conformité, et il a une particularité : il est bloquant par construction. La validation de l'AIPD par le DPO et la conformité RGPD/HDS sont des conditions de go-live, pas des options l'objectif SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini) correspondant est binaire, soit c'est opérationnel au jour 1, soit on diffère. Un retard sur ce volet, ou pire un manquement détecté après mise en production, expose l'établissement à un risque juridique et réputationnel sans commune mesure avec les autres. On le traite en engageant le DPO très en amont et en faisant de la conformité un jalon explicite du planning, pas une vérification de dernière minute.

Aucun de ces risques ne condamne le projet mais chacun explique pourquoi le Go qu'on recommande n'est pas un Go inconditionnel. Il s'accompagne de garde-fous précis, d'un suivi des risques en COPIL et d'un déploiement progressif. C'est cette lucidité sur les risques qui rend la recommandation crédible, et c'est l'objet de la section suivante.

Recommandation : implémentation ou non

La recommandation est un feu vert. Pas un feu vert enthousiaste qui balaie les difficultés, mais un feu vert raisonné : l'analyse qui précède montre un besoin réel et documenté, une valeur opérationnelle qui rembourse le développement dès la première année pleine sur le seul levier secrétariat, et un marché qui confirme que la prise de rendez-vous en ligne est un standard attendu, pas un pari technologique. Les conditions sont réunies pour engager le budget de développement.

Le fait de ne pas procéder à la refonte reviendrait à maintenir l'existant un logiciel desktop vieillissant, un standard téléphonique saturé, 25 % de no-show et une quinzaine d'ETP dont une part significative du temps part dans la prise de RDV au téléphone. Ce statu quo a un coût, simplement il ne se voit pas parce qu'on s'y est habitué. Ne rien faire, c'est choisir de continuer à payer ce coût indéfiniment. L'option intermédiaire adopter un SaaS du marché plutôt que construire a été examinée dans le benchmark : elle règle le problème fonctionnel mais au prix de la maîtrise du parcours patient, de la donnée et de l'intégration au SIH, et avec un coût récurrent par praticien qui, à l'échelle d'un CH, finit par rejoindre celui d'un build. Le pari du build se justifie précisément là où un hôpital diffère d'un cabinet : il veut rester propriétaire de son outil.

Mais ce Go est conditionnel, et les conditions ne sont pas négociables. La première est la conformité : l'AIPD validée par le DPO et le socle RGPD/HDS opérationnel sont des prérequis de go-live, pas des livrables qu'on rattrape après coup c'est l'objectif binaire qu'on s'est fixé. La deuxième est l'adoption pilotée : déploiement par paliers sur un service pilote, conduite du changement et formation engagées dès le départ, parce que tout le ROI en dépend. La troisième est la contractualisation propre de l'hébergement HDS, avec SLA et réversibilité, pour ne pas troquer une dépendance contre une autre. La quatrième est le suivi des risques en COPIL, mois après mois, plutôt qu'une vérification de dernière minute.

C'est à ces conditions que le projet tient sa promesse. Elles ne fragilisent pas la recommandation, elles la rendent crédible : un Go qui nomme ses propres garde-fous

est un Go sur lequel une direction peut s'engager sans naïveté. La note de cadrage qui suit traduit cet accord de principe en périmètre, objectifs mesurables, budget et gouvernance elle transforme le « oui » en plan d'exécution.